ETUDE DE L'ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES CANCERS DANS UN ESPACE RÉGIONAL : CAS DES FORMATIONS SANITAIRES DE LA RÉGION DES HAUTS-BASSINS (BURKINA FASO)

Dr Alioun TRAORE

Auteurs et coauteurs : A TRAORE[1] ; M Z MEDA[2], B ILBOUDO[3]

1: Service d'anatomie et de cytologie pathologiques, Centre Hospitalier Universitaire SOURO SANOU
2: Service de l'Information, de la Recherche, de l'Epidémiologie et de la Planification, Centre Hospitalier Universitaire Sourô Sanou, Bobo-Dioulasso, Burkina Faso
3: Centre MURAZ de BOBO, Direction Générale de l'Offre des Soins

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

INTRODUCTION (1/3)

- Maladie non transmissible: +++ décès dans le monde
- Cancer : un décès sur six dans le monde
- OMS 2024, 41 millions de décès/an; 70% PFR
- BFA,14538 nouveaux cas, 2e cause de mortalité hôpitaux
- Région des Hauts Bassins : données similaires à celles nationales

INTRODUCTION (2/3)

- PEC complexe, coûteuse et multidisciplinaire.
- Multiples prestataires à différents niveaux organisationnels du système de soins
- D'où l'importance de la coordination des soins entre différentes structures et aussi entre prestataires.
- Coordination des soins: soins flexibles, centré patient, réduire les coûts

INTRODUCTION (3/3)

Région des Hauts-Bassins

organisation de la prise en charge des cancers

↓

espace régional

↓

des formations sanitaires

METHODOLOGIE(1/4)

❖ **Cadre d'étude**

La région des Hauts Bassins nous a servi de cadre d'étude

❖**Type et période d'étude**

Il s'est agi d'une étude transversale suivant une approche qualitative: 1er Mars 2023 à 15 juillet 2024 dans formations sanitaires région des Hauts-Bassins.

METHODOLOGIE(2/4)

❖**Échantillon et échantillonnage**

- choisi raisonné: 32 prestataires:
- 5 sage-femmes dont un Maïeuticien
- 16 Médecins spécialistes
- 10 Médecins généralistes
- Un pharmacien spécialiste

METHODOLOGIE(3/4)

❖**Variables: Outils et techniques de collectes des données**

- Approche qualitative.
- Entretien individuel réalisé avec tous les participants
- Téléphone portable pour l'enregistrement des informations pendant l'enquête.

METHODOLOGIE(4/4)

❖ **Saisie et analyse des données**

- Entretiens ont été tous transcrits manuellement.
- prises de notes
- Différentes observations classées en fonction des thématiques
- Analyse : Excel 2021

RESULTATS(1/7)

❖ Caractéristiques sociodémographiques

- 32 professionnels de santé : rencontrés individuellement
- Age : 34ans et 65ans (moyenne de 44,2ans)
- Années d'expérience : 1an et 34 ans (moyenne 9,4ans)

RESULTATS(2/7)

❖ Caractéristiques sociodémographiques

- structures
  - 4 agents étaient du CMU/CSPS
  - 6 étaient des CMA
  - 21 étaient du CHU
  - 1 de la DRS.

RESULTATS(3/7)

❖ **Organisation des services**

▪ **Importance de l'organisation de l'offre des soins**

- Création d'un service d'oncologie
- Former le personnel en quantité et en qualité
- Fournir du matérielle
- Organiser les réunions de concertation pluridisciplinaire

RESULTATS(4/7)

- **Organisation des services**

- **Importance de l'organisation de l'offre des soins**

« Je pense qu'il est très important d'organiser cette PEC, afin de réduire le délai de mise en route du traitement et le respect des protocoles thérapeutiques ».

« Un malade souffrant de cancer est saucissonné entre les médecins spécialistes.. »

RESULTATS(5/7)

❖ Disponibilité de l'offre de soins et services de santé

- **Services de soins offerts**
  - Ensemble : offre disponible mais insuffisant
  - Fonction du degré de compétence et du plateau technique disponible
  - Ressources matérielles insuffisantes:

« il faut avoir un bloc où on peut opérer à tout moment les patients souffrant de cancer. Mais au CHU, nos malades sont programmés comme tous les autres malades, donc pour un problème de bloc, on peut faire un mois, deux mois sans pouvoir opérer un cas de cancer, ….. ».

RESULTATS(6/7)

❖ Accessibilité des services de santé

Accessibilité était multidimensionnelle

- Financière: conduisait les patients a arrêté le traitement

« La prise en charge du cancer est trop onéreuse. Ailleurs c'est subventionné. Ici, les médicaments anti-cancéreux coûtent ***au moins 150 000f par cure*** *et* ***300 000F à 400 000F par cure*** *pour les cancers de l'estomac ou du colon».*

RESULTATS(7/7)

❖ Accessibilité des services de santé

- Géographique ⟹ malades vers les tradipraticiens
- sociale : stigmatisations, dépression, esprit d'envoutement

« …*il y a plein de patients qui souffrent de la dépression* »

CONCLUSON

- Résultats de notre étude appellent à une meilleure organisation de la prise charge des pathologies cancéreuses au même titre que celles non cancéreuses.
- Disponibilisation des ressources,
- Mise en place d'un cadre de concertation entre acteurs et décideurs
- Registre de cancer

Merci pour votre attention